2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

CARD INTERATIVO COMO INDUTOR DE BOAS PRÁTICAS NO MANEJO E VIGILÂNCIA DA SÍFILIS GESTACIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Aline Azevedo Vidal – SMS-RJ / UFRJ
Millena Alves de Souza – SMS-RJ
Danielle Nogueira de Oliveira – SMS-RJ
Rose Procópio Chelucci – SMS-RJ / UFRJ
Vanessa Alvares Henriques – SMS-RJ / UFRJ

Card interativo para qualificação assistencial no manejo da sífilis em gestante

A experiência em uma unidade de APS da zona oeste do município do Rio de Janeiro revelou desafios críticos no manejo da sífilis gestacional, como falhas nos registros, inconsistências entre sistemas de informação e fragilidades no seguimento clínico das gestantes. A análise situacional evidenciou lacunas importantes no controle laboratorial e na condução do cuidado, impactando diretamente a qualidade da assistência e o risco de transmissão vertical. Como resposta, foi desenvolvido um card interativo, um produto técnico-tecnológico prático e acessível, reunindo orientações claras sobre diagnóstico, tratamento, monitoramento e manejo de parcerias. A ferramenta surgiu como estratégia inovadora para padronizar condutas, apoiar os profissionais da APS e fortalecer a articulação do cuidado. A iniciativa demonstra que o uso de tecnologias educacionais pode transformar práticas assistenciais, qualificando o acompanhamento das gestantes e contribuindo de forma concreta para a redução da sífilis congênita.

Introdução

O manejo da sífilis gestacional requer diagnóstico oportuno, tratamento correto da gestante e de suas parcerias sexuais e monitoramento laboratorial. As fragilidades nos registros, seguimento clínico e articulação em rede comprometem a qualidade do cuidado na APS. Nesse contexto, tecnologias educacionais e produtos técnico-tecnológicos (PTT) podem qualificar práticas assistenciais e de vigilância no âmbito do SUS.

Objetivos

Descrever a experiência de diagnóstico situacional da sífilis gestacional em uma unidade de APS da zona oeste do Rio de Janeiro, destacando a elaboração de um card interativo como PTT para qualificação do manejo da doença.

Métodos

Relato de experiência realizado em 2025, com análise de dados de gestantes com sífilis provenientes do SINAN, prontuário eletrônico e planilhas da área técnica.

Resultados

Identificaram-se discrepâncias entre sistemas de informação, registros incompletos, fragilidades no controle do VDRL e falhas na continuidade do cuidado. Como resposta, desenvolveu-se um card interativo com diretrizes práticas sobre diagnóstico, tratamento, acompanhamento laboratorial e gestão de parcerias e foco na padronização de condutas.

Conclusão/Considerações finais

O diagnóstico situacional evidenciou falhas no manejo da sífilis gestacional e impulsionou a criação de uma solução inovadora. O card interativo mostrou-se ferramenta estratégica para qualificar registros, fortalecer o seguimento clínico e contribuir para a redução da transmissão vertical.

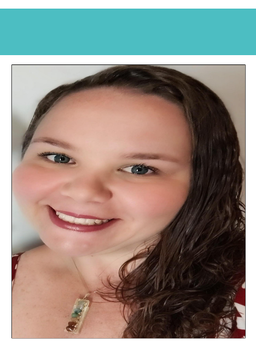
Matriz de avaliação do Card Interativo para Manejo da Sífilis Gestacional na APS

Dimensão	Indicadores Avaliativos	Critérios de Análise	Evidências Observadas
Inovação	Adequação do produto ao contexto da APS	Alinhamento entre o conteúdo do card e as demandas reais do processo de trabalho	Produto construído a partir de diagnóstico situacional, refletindo fragilidades reais do serviço
	Usabilidade	Facilidade de compreensão e consulta rápida durante o atendimento	Linguagem objetiva, organização visual e estrutura interativa
	Integração assistência–vigilância	Capacidade de reunir aspectos clínicos e de notificação	Inclusão de orientações para diagnóstico, tratamento, acompanhamento laboratorial e registros
Impacto	Qualificação do manejo clínico	Apoio à tomada de decisão e padronização de condutas	Organização de fluxos e critérios terapêuticos conforme protocolos vigentes
	Melhoria dos registros	Potencial para reduzir inconsistências e omissões nos sistemas de informação	Enfoque nos pontos críticos identificados nos sistemas utilizados
	Redução da transmissão vertical	Contribuição indireta para interrupção da cadeia de transmissão	Ênfase no tratamento oportuno da gestante e de suas parcerias
Aplicabilidade	Uso no cotidiano do serviço	Possibilidade de utilização durante consultas, visitas e discussões de caso	Ferramenta de fácil acesso e uso contínuo
	Aceitabilidade pela equipe	Potencial de adesão pelos profissionais	Linguagem acessível e formato visual atrativo
	Integração aos fluxos internos	Capacidade de apoiar a organização do cuidado	Orientações compatíveis com a rotina da APS
Replicabilidade	Adaptabilidade	Possibilidade de adequação a diferentes territórios	Baseado em diretrizes nacionais
	Custo	Viabilidade financeira para os serviços	Desenvolvido em plataforma gratuita
	Escalabilidade	Potencial de ampliação para outras unidades	Formato digital de fácil compartilhamento
Sustentabilidade	Atualização do conteúdo	Facilidade de revisão conforme mudanças normativas	Plataforma permite edição contínua
	Manutenção no serviço	Possibilidade de uso prolongado	Não depende de recursos externos ou tecnologia complexa

Check list – Sífilis Gestacional

CHECK LIST - SÍFILIS GESTACIONAL	SIM	NÃO
1. Gestante com notificação em anos anteriores de sífilis gestacional?		
2. Nome(s) da(s) parceria(s) sexual(s) constam em prontuário?		
3. Teste rápido solicitado e realizado, após aconselhamento pré-teste de Sífilis com resultados devidamente registrados em prontuário e em cartão de gestante?		
4. CID de Sífilis gestacional devidamente ativado?		
5. Realizado notificação com registro do número do SINAN em prontuário?		
6. Início de tratamento oportuno no mesmo dia do diagnóstico?		
7. Realizado VDRL diagnóstico antes do início do tratamento?		
8. Solicitado VDRL mensal durante período gestacional?		
9. Realizado registro do resultado do VDRL mensal em prontuário e em cartão de gestante?		
10. Doses aplicadas dentro do aprazamento correto, com registro em prontuário das datas e registro em caderneta da gestante?		
11. Gestante necessitou de retratamento?		
12. Doses de retratamento aplicadas dentro do aprazamento correto, com registro em prontuário das datas e registro em caderneta da gestante?		
13. Teste rápido da parceria sexual solicitado e realizado, após aconselhamento pré-teste de Sífilis com resultados devidamente registrados em prontuário?		
14. Doses aplicadas na(s) parceria(s) sexual(ais) dentro do aprazamento correto, com registro em prontuário das datas e registro em caderneta da gestante?		
15. Caso parceria(s) sexual(ais) não tratada(s), foram realizadas e registradas estratégias para vinculação e adesão ao tratamento? Quais os esgotamentos realizados?		
16. Realizado registro de aconselhamento sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis e uso de preservativos em todas as relações durante o pré-natal?		
17. Realizado classificação de vulnerabilidade/risco, e seguimento com Equipe e-Multi quando encontrado?		

INSTITUIÇÃO: SMS-RJ / UFRJ
AUTOR PRINCIPAL: Aline Azevedo Vidal
VÍNCULO: SMS-RJ
E-mail: alineavidal86@gmail.com
CONTATOS: (21) 976656396



Rio PREFEITURA